

2026 年高齢夏季受験対策講座 模擬問題

【予想問題】 高齢者福祉

日本の高齢者を取り巻く社会情勢

問題 1

「令和 8 年版高齢社会白書」（内閣府）及び厚生労働省の資料等に示された、近年の日本の高齢者を取り巻く社会情勢に関する次の記述のうち、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

- 1 令和 7 年（2025 年）には、団塊の世代が全て 75 歳以上となったことから、65 歳以上人口が総人口に占める割合（高齢化率）は 35%を超えた。
- 2 令和 6 年（2024 年）に公表された認知症高齢者の将来推計によると、2040 年には 65 歳以上の認知症高齢者が約 584 万人となる一方、軽度認知障害（MCI）の高齢者は約 100 万人にとどまると見込まれている。
- 3 65 歳以上の者がいる世帯についてみると、令和 6 年（2024 年）には「夫婦のみの世帯」が「単独世帯」を上回り、最も多い世帯構造となっている。
- 4 65 歳以上の一人暮らしの者の割合は、将来にわたって男女ともほぼ横ばいで推移すると見込まれており、2050 年においても男性・女性とも 20%未満にとどまると推計されている。
- 5 高齢者の就業は長期的に増加傾向にあり、65～69 歳の就業状況をみても、現在ではおおむね半数を超える者が就業している。

↓ 正答

5

解説

1 不適切

2025 年には団塊の世代が全て 75 歳以上となりましたが、高齢化率が 35%を超えたわけではありません。2024 年の高齢化率は**29.3%**です。

2 不適切

2040 年の認知症高齢者は約 584 万人と推計されていますが、MCI は約 100 万人ではなく約 613 万人と推計されています。

3 不適切

65 歳以上の者がいる世帯では、2024 年に**単独世帯が 32.7%、夫婦のみの世帯が 31.8%**となり、単独世帯が最も多くなっています。

4 不適切

65 歳以上の一人暮らしは今後も増加すると見込まれています。2050 年には、65 歳以上の一人

暮らしの割合は**男性約 26%、女性約 29%**と推計されています。

5 適切

高齢者の就業は長期的に増加傾向にあります。65～69 歳についても、現在では半数を超える水準で就業しています。

【重要ポイント】

高齢化率：2024 年 29.3%

2040 年の認知症高齢者：約 584 万人

2040 年の MCI：約 613 万人

高齢者のいる世帯：単独世帯 > 夫婦のみの世帯

2050 年の 65 歳以上一人暮らし：約男性 26%、女性 29%

65～69 歳の就業：半数超

【予想問題】 高齢者福祉（日本の高齢者福祉制度の発展過程）

問題 2 日本の高齢者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 1973 年（昭和 48 年）の老人福祉法改正によって、70 歳以上の高齢者を対象とした老人医療費公費支給制度が導入され、医療費の自己負担が無料化された。

2 1989 年（平成元年）に策定された「高齢者保健福祉推進十か年戦略」（ゴールドプラン）によって、老人保健福祉計画の策定が市町村に義務づけられた。

3 1990 年（平成 2 年）の福祉関係八法改正によって、特別養護老人ホームへの入所措置等の権限が市町村から都道府県へ移管された。

4 2005 年（平成 17 年）の介護保険法改正によって、高齢者の複合的な生活課題に対応するため、市町村に「重層的支援体制整備事業」が創設された。

5 2023 年（令和 5 年）に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」によって、市町村は「市町村認知症施策推進計画」を策定しなければならないとされた。

｜【解答と解説】

正解：1

1：適切 1973 年（昭和 48 年、いわゆる「福祉元年」）の老人福祉法改正により、70 歳以上の高齢者を対象に医療費の自己負担分を公費で賄う老人医療費公費支給制度（医療費無料化）が実施されました。その後、医療費の急増と社会的入院の増加が社会問題となり、1982 年の老人保健法制定（自己負担の一部導入）へとつながっていきます。

2：不適切 「ゴールドプラン」は 1989 年（平成元年）に策定された高齢者保健福祉推進十か

年戦略ですが、市町村および都道府県に対する「老人保健福祉計画」の策定義務づけは、1990年（平成2年）の「福祉関係八法改正」によって行われました。施策（プラン）と法改正（法律）の年号・内容のズレは国家試験の頻出引っかけポイントです。

3：不適切 1990年（平成2年）の福祉関係八法改正では、住民に身近な自治体が責任を持って対応できるよう、特別養護老人ホームへの入所措置等の権限が「都道府県から市町村へ」一元化（権限移譲）されました。記述は移管の方向が逆になっています。

4：不適切 2005年（平成17年）の介護保険法改正で創設されたのは、「予防給付（新予防給付）」「地域密着型サービス」「地域包括支援センター」などです。「重層的支援体制整備事業」は、属性を問わない相談支援体制を整備するため、2020年（令和2年）の社会福祉法改正によって創設されました（2021年4月施行）。

5：不適切 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」において、国が策定する「認知症施策推進基本計画」は義務（閣議決定）ですが、都道府県が策定する「都道府県認知症施策推進計画」および市町村が策定する「市町村認知症施策推進計画」は、ともに策定するよう「努めなければならない」（努力義務）と規定されています。「策定しなければならない（義務）」とする記述は誤りです。

【予想問題】高齢者福祉（介護保険制度の費用・給付等）

問題3 介護保険制度における費用負担や保険給付に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。

1 高額介護サービス費は、利用者が支払った利用者負担の合計額が一定の上限額を超えた場合に支給されるが、施設入所時における食費や居住費（滞在費）は算定対象に含まれない。

2 厚生労働大臣が介護報酬の算定基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会（中医協）の意見を聴かなければならない。

3 第1号被保険者のうち、現役並みの所得を有する者の介護サービス利用時の自己負担割合は、原則として5割と定められている。

4 介護給付費に要する費用の財源構成は、原則として公費が50%、保険料が50%とされており、保険料の内訳は第1号被保険者と第2号被保険者の人口比率に応じて見直される。

5 第2号被保険者の介護保険料は、市町村が直接、年金からの天引き（特別徴収）または納付書（普通徴収）によって徴収する。

｜【解答と解説】

正解：1、4

1：適切

高額介護サービス費は、1 か月間に支払った介護保険の自己負担額（1～3 割負担分）の世帯合計が所得に応じた自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が支給される制度です。ただし、施設サービスやショートステイ利用時の食費・居住費（滞在費）、日常生活費、差額ベッド代などは合算の対象外（全額自己負担）となります。

2：不適切

介護報酬の算定基準を定めるときに意見を聴く機関は「社会保障審議会（介護給付費分科会）」です。「中央社会保険医療協議会（中医協）」は、医療保険における診療報酬の改定等を審議する機関ですので混同しないよう注意が必要です。

3：不適切

介護サービス利用時の自己負担割合は原則「1 割」です。第 1 号被保険者のうち一定以上の所得を有する者は「2 割」、さらに現役並みの所得を有する者は「3 割」となります。「5 割」とする記述は誤りです。

4：適切

介護給付・予防給付に要する費用は、原則として公費 50%、保険料 50%で構成されています。公費の負担割合は、居宅給付費等では国 25%、都道府県 12.5%、市町村 12.5%ですが、施設等給付費では国 20%、都道府県 17.5%、市町村 12.5%となります。保険料の第 1 号・第 2 号の負担割合は、人口比を基に 3 年ごとに見直されます。

5：不適切

年金からの特別徴収や納付書による普通徴収によって市町村が直接徴収するのは「第 1 号被保険者」の保険料です。第 2 号被保険者（40 歳以上 65 歳未満）の保険料は、加入している各医療保険者（健康保険組合、協会けんぽ、市町村国保など）が医療保険料と一体的に徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通じて各市町村に交付されます。

【予想問題】高齢者福祉（高齢者の住まいと相談援助）

問題 4 地域包括支援センターの社会福祉士 A のもとに、一人暮らしの D さん（78 歳、要支援 2）と長男が相談に訪れた。事例を読んで、A による D さん親子への高齢者の住まいに関する助言・説明として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

1 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）への入所要件は従来は要介護 3 以上であったが、介護報酬改定により、現在は要支援状態であっても生活に不安があれば市町村の判断で入所申込みが可能であると説明した。

2 サービス付き高齢者向け住宅は、状況把握（安否確認）と生活相談サービスが必須とされており、入居後も外部の介護保険サービスを個別に契約して利用できると助言した。

3 養護老人ホームは、事業者との直接契約によって入所する施設であり、要支援の認定を受けていれば所得制限なく入所できると説明した。

4 住宅型有料老人ホームに入居した場合、介護保険法により、施設の職員以外の外部の介護サービス事業者から訪問介護等の居宅サービスを受けることは認められていないと説明した。

5 住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅（セーフティネット住宅）に入居するためには、あらかじめ介護保険の要介護認定を受けていることが必須要件であると助言した。

｜【解答と解説】

正解：2

1：不適切

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）への新規入所は、原則として「要介護3以上」と定められており、近年の介護報酬改定等においてもこの原則は変わっていません（やむを得ない事由による特例入所の対象も「要介護1または2」の者に限られます）。要支援2であるDさんは入所対象とはなりません。

2：適切

「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）」に基づくサービス付き高齢者向け住宅（一般型）は、ケアの専門家等による「状況把握（安否確認）サービス」と「生活相談サービス」の提供が義務づけられています。また、介護が必要になった場合には、入居者が自由に外部の介護保険サービス事業者（訪問介護や通所介護など）と個別に契約してサービスを利用しながら住み続けることが可能です。

3：不適切

養護老人ホームは、老人福祉法に基づく市町村の「措置」によって入所する施設です（事業者との直接契約ではありません）。また、入所要件は「65歳以上で、身体上・精神上・環境上の理由および経済的理由により居宅での生活が困難な者」と規定されており、所得制限（経済的要件）が課されます。

4：不適切

住宅型有料老人ホームは、食事等のサービスが提供される高齢者向け住宅ですが、介護サービス自体は提供しません。入居者が介護を必要とする場合は、外部の介護保険サービス事業所（訪問介護等）と個別に契約して居宅サービスを利用する仕組みとなっています。「外部からの居宅サービスを受けることは認められていない」とする記述は誤りです。

5：不適切

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）」に基づく登録住宅（セーフティネット住宅）は、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の入居を拒まない賃貸住宅です。入居にあたって介護保険の要介護認定を受けていることは必須要件ではありません。

【予想問題】 高齢者福祉（多職種連携と専門職の役割）

問題 5 事例を読んで、介護老人保健施設の支援相談員である A 職員（社会福祉士）が、退所前カンファレンスにおいて、利用者の家庭復帰に向けた支援内容を検討するにあたり、施設に勤務する他の職員に専門的な意見を求める際、最も適切な職種を 1 つ選びなさい。

〔事例〕

入所後 3 か月が経過した E さん（76 歳、要介護 2）は、脳梗塞の後遺症により右片麻痺と軽度の注意障害が残っているが、「できるだけ早く自宅に戻り、自分で衣服の着脱や趣味の軽調理を行いたい」と希望している。杖歩行などの基本動作は安定してきたものの、ボタン留めや包丁・スプーンの使用といった細かな手作業に困難を感じている。A は、退所後の生活環境を見据え、E さんに適した自助具の選定や、家事・身の回り動作といった応用的動作能力の訓練状況について専門的な助言を得たいと考えた。

1 理学療法士

2 作業療法士

3 言語聴覚士

4 義肢装具士

5 歯科衛生士

｜【解答と解説】

正解：2

1：不適切

理学療法士（PT）は、身体に障害のある者に対し、主として寝返り、起き上がり、立ち上がり、歩行といった「基本動作能力」の回復を図るための運動療法や物理療法を行います。本事例のような手先の細かな動作や家事動作などの「応用的動作能力」に対する専門職ではありません。

2：適切

作業療法士（OT）は、身体または精神に障害のある者に対し、主としてその「応用的動作能力（食事・更衣・排泄・家事動作など）」や「社会的適応能力」の回復を図るための訓練や指導を行います。また、本事例のようなボタンエイドや使いやすいスプーン等の「自助具の選定・作成」や住環境への適応支援も作業療法士の専門領域です。

3：不適切

言語聴覚士（ST）は、音声機能、言語機能、聴覚に障害のある者、ならびに摂食・嚥下機能に障害のある者に対して、機能の維持向上を図るための検査、訓練、指導等を行います。

4：不適切

義肢装具士（PO）は、医師の指示のもとで、義肢（義手・義足）や装具（下肢装具・コルセットなど）の採型、製作、身体への適合を行う専門職です。一般的な自助具を用いた動作訓練や応用的動作能力全般の評価を行う職種ではありません。

5：不適切

歯科衛生士は、歯科医師の指導のもとで、歯・口腔の疾患予防処置（歯石除去やフッ化物塗布など）、歯科診療補助、口腔衛生指導を行う専門職です。

【予想問題】高齢者福祉（地域包括支援センターの権利擁護業務と多機関連携）

問題 6 事例を読んで、地域包括支援センターの A 社会福祉士による権利擁護や消費者被害等への初期対応として、最も適切なものを 1 つ選びなさい。

〔事例〕

一人暮らしの F さん（83 歳、要介護 1）について、民生委員から「最近、見慣れない訪問販売業者が頻繁に出入りし、高額な商品を次々と契約させられているようだ。F さんは認知症の症状が進んでおり、契約したこと自体をよく覚えていない」と地域包括支援センターに相談があった。A 社会福祉士が F さん宅を訪問したところ、数日前に契約したばかりの高額な布団一式（特定商取引法の訪問販売に該当）の未開封の箱と契約書面が見つかった。また、預貯金の管理や金銭管理にも大きな不安を抱えている状態であった。

1 訪問販売による契約から間もないため、消費生活センター等と連携を図りながら、クーリング・オフ等による契約解除に向けた手続きを速やかに支援した。

2 親族による申立てが困難な状況を確認したため、老人福祉法に基づく市町村長による後見開始の審判の申立てに向けて、管轄の簡易裁判所へ提出する書類の準備を進めた。

3 F さんの金銭管理の不安を解消するため、認知症の進行により契約内容の理解が困難な状態であっても支援を受けられる、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」の利用手続きを進めた。

4 「高齢者虐待防止法」に基づき、訪問販売業者による行為が「経済的虐待」と認定される可能性を想定して、市町村長による立入調査を速やかに実施した。

5 消費者被害の再発を防止するため、福祉事務所と連携し、福祉事務所長の職権で F さんの金融機関口座を直ちに凍結する手続きを行った。

― 【解答と解説】

正解：1

1：適切

訪問販売による契約の場合、法定の契約書面を受け取った日から 8 日以内であれば無条件で契約を解除（クーリング・オフ）することができます。地域包括支援センターの社会福祉士は、消費生活センター等の専門機関と連携しながら、クーリング・オフの通知や悪質商法による消費者被害の救済に向けた支援を行うことが極めて適切です。

2：不適切

身寄りがいないなど親族による申立てが期待できない場合に、老人福祉法に基づき市町村長が法定後見の審判を申し立てる（市町村長申立て）こと自体は適切ですが、後見開始の審判の申立先となる管轄機関は「家庭裁判所」です。「簡易裁判所（または地方裁判所）」ではありません。

3：不適切

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）は、社会福祉協議会との「契約」に基づいてサービスを利用する事業であるため、事業の契約内容について判断し得る能力（契約締結能力）を有していることが要件となります。認知症等により契約内容の理解が困難な状態である場合は本事業の対象とはならず、成年後見制度の利用等を検討する必要があります。

4：不適切

「高齢者虐待防止法」における虐待の対象（行為者）は、「養護者（家族・親族・同居人等）」および「養介護施設従事者等（介護保険施設や事業所の職員等）」に限定されています。本事例のような訪問販売業者等の第三者による悪質商法や詐欺的行為は、同法における虐待の定義には含まれません（消費者問題・警察案件等として対応します）。

5：不適切

福祉事務所やその長、社会福祉士等に、個人の金融機関口座を職権で凍結・停止するような法的権限はありません。口座管理や財産侵害への対応が必要な場合は、成年後見制度の申立て手続きや金融機関との相談・連携を通して進める必要があります。

【予想問題】高齢者福祉（日本の高齢者を取り巻く社会情勢・国際比較）

問題7「令和8年版高齢社会白書」（内閣府）等を示された日本の高齢者を取り巻く社会情勢に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口（令和5年推計）によると、総人口に占める65歳以上人口の割合（高齢化率）は、2070年（令和52年）には45%を超えると見込まれている。

2 世界の高齢化の状況を比較すると、総人口に占める65歳以上人口の割合（高齢化率）は、日本がイタリアやドイツなどの高齢先進国を上回っている。

3 日本の高齢化の進行速度をみると、高齢化率が7%から14%に達するまでに要した年数（倍加年数）よりも、14%から21%（超高齢社会）に達するまでに要した年数の方が長かった。

4 高齢者の健康について、日常生活に制限のない期間を示す「健康寿命」と「平均寿命」の差（日常生活に制限のある期間）をみると、女性よりも男性の方が長くなっている。

5 65歳以上の者の死因別死亡率をみると、第1位の「悪性新生物（がん）」に次いで、第2位

が「肺炎」、第3位が「心疾患」となっている。

｜【解答と解説】

正解：2

1：不適切

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年／2023年推計）」によると、2070年（令和52年）の高齢化率は出生中位・死亡中位推計で約38.7%、最も高齢化率が高く推計される出生低位・死亡低位（あるいは死亡中位）推計でも約42.0%と見込まれており、いずれの仮定においても45%を超える推計にはなっていません。

2：適切

内閣府「高齢社会白書（国際比較データ）」および国連「World Population Prospects」によると、日本の高齢化率（約29%台）は、ヨーロッパの高齢先進国であるイタリア（約24%台）やドイツ（約23%台）、ポルトガル、フィンランドなどを上回り、主要先進国の中で最も高い水準となっています。

3：不適切

日本の高齢化は段階が進むにつれてさらに加速しました。高齢化率が7%（高齢化社会）から14%（高齢社会）に達するまでに要した年数（倍加年数）は24年間（1970年～1994年）であったのに対し、14%から21%（超高齢社会）へ達するまでに要した年数はわずか13年間（1994年～2007年）でした。「14%から21%に達するまでに要した年数の方が長かった」とする記述は誤りです。

4：不適切

厚生労働省データ（第17回健康日本21推進専門委員会資料、令和4年/2022年調査値）および白書記載データによると、平均寿命と健康寿命の差（日常生活に制限のある期間）は、男性が約8.8年、女性が約11.9年となっています。女性の方が平均寿命が長い分、日常生活に制限のある期間も「女性の方が男性よりも長い」ため、本記述は誤りです。

5：不適切

厚生労働省「人口動態統計（令和5年／2023年確定数）」および内閣府「令和7年版・令和8年版高齢社会白書（第1章第2節 健康・福祉）」によると、65歳以上人口10万人当たりの死因別死亡率は、第1位「悪性新生物（がん）」（939.3）、第2位「心疾患（高血圧性を除く）」（587.7）、第3位「老衰」（482.0）の順となっています（第4位は脳血管疾患、第5位が肺炎）。近年は「老衰」による死亡率が大きく上昇しています。

【予想問題】高齢者福祉（日本の高齢者保健福祉制度の展開過程）

問題 8 第二次世界大戦後の日本における高齢者保健福祉制度の展開過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 1963 年（昭和 38 年）の老人福祉法の制定において、65 歳以上の高齢者を対象とした健康診査の実施とともに、老人デイサービス事業が同法に規定され法定化された。

2 1982 年（昭和 57 年）の老人保健法の制定において、医療費の急増と社会的入院の解消を図るため、病状安定期の高齢者を受け入れる老人保健施設（現・介護老人保健施設）が創設された。

3 1989 年（平成元年）に策定された「高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）」において、在宅介護の相談窓口等の基盤整備として、地域包括支援センターを全国に設置する整備目標が掲げられた。

4 1990 年（平成 2 年）の福祉関係八法改正において、在宅福祉の推進を図るため、老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業の「在宅三事業」が老人福祉法に位置づけられ法定化された。

5 2005 年（平成 17 年）の介護保険法改正において、軽度者に対する給付の見直しを図るため、要支援者を対象とする予防給付が廃止され、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業へ全面的に移行された。

｜【解答と解説】

正解：4

1：不適切

1963 年（昭和 38 年）に制定された老人福祉法では、65 歳以上の者に対する健康診査の実施や、老人福祉施設（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人憩の家）の設置などが規定されました。老人デイサービス事業（および老人居宅介護等事業、老人短期入所事業の「在宅三事業」）が老人福祉法に規定され法定化されたのは、1990 年（平成 2 年）の「福祉関係八法改正」です。

2：不適切

1982 年（昭和 57 年）の老人保健法制定時には、老人医療費の自己負担（一部負担金）の導入や保健事業（健康診査・健康教育等）の創設が行われました。病状安定期の高齢者に対し、医学的管理のもとで看護・介護・リハビリ等を提供する「老人保健施設（現在の介護老人保健施設）」が創設されたのは、1986 年（昭和 61 年）の老人保健法改正（1988 年施行）です。

3：不適切

1989 年（平成元年）に策定された「ゴールドプラン」において、在宅介護の総合的な相談・連絡調整機関として全国 1 万か所の整備目標が掲げられたのは「在宅介護支援センター」です。

「地域包括支援センター」は、2005 年（平成 17 年）の介護保険法改正（2006 年施行）によって創設されました。

4：適切

1990 年（平成 2 年）の福祉関係八法改正では、施設福祉中心から在宅福祉を重視する方向への転換が図られ、「老人居宅介護等事業（ホームヘルプ）」「老人デイサービス事業」「老人短期入所事業」の在宅三事業が老人福祉法に正式に規定されました。また、特別養護老人ホーム等への入所措置権限が都道府県から身近な市町村へと一元化されました。

5：不適切

2005 年（平成 17 年）の介護保険法改正で導入されたのは、要支援 1・2 の者を対象とする「予防給付（新予防給付）」や「地域支援事業（介護予防事業等）」の創設です。要支援者を対象とする訪問介護・通所介護が予防給付から「介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業）」へと移行されたのは、2014 年（平成 26 年）の介護保険法改正（2015 年施行、2017 年 4 月までに全自治体で実施）です。

予想問題】高齢者福祉（介護予防サービス・地域密着型サービスの対象と相談援助）

問題 9 事例を読んで、地域包括支援センターの D 社会福祉士による長女への助言・提案として、適切なものを 2 つ選びなさい。

〔事例〕

自宅で一人暮らしの K さん（81 歳、女性）は、変形性膝関節症のため歩行が不安定になり、要支援 2 の認定を受けている。最近、自宅の浴槽をまたぐ際にふらつき、自宅での入浴に不安を抱えるようになった。また、これまで近隣の病院へ通院してリハビリを行っていたが、通院が負担になってきており、「専門職による運動指導を受けながら足腰を鍛え、外へ出る機会も持ちたい」と希望している。離れて暮らす長女から地域包括支援センターの D 社会福祉士に「母の生活を支えるために、どのようなサービスや支援を利用できるか」と相談があった。

1 リハビリテーション専門職による機能訓練や運動指導を受けるため、介護予防通所リハビリテーションの利用を提案した。

2 自宅での入浴を安全に行うため、入浴補助用具の購入にかかる介護予防特定福祉用具購入費の支給申請を提案した。

3 夜間も含めた日々の安否確認や随時の身体介護に対応するため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用を提案した。

4 通い・泊まり・訪問看護を一体的に組み合わせたケアを受けるため、看護小規模多機能型居宅介護の利用を提案した。

5 集中的なリハビリと日常生活動作訓練を受けるため、介護老人保健施設への入所を提案した。

｜【解答と解説】

正解：1、2

1：適切

介護予防通所リハビリテーション（デイケア）は、介護老人保健施設や病院・診療所等において、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門職による機能訓練やリハビリテーションを提供する予防給付サービスであり、要支援1・2の認定を受けた者が利用できます。通院が困難になってきたKさんの運動指導や外出機会のニーズに合致した適切な助言です。

2：適切

介護予防特定福祉用具購入費は、居宅要支援被保険者（要支援1・2）を対象とした予防給付の一つです（同一年度内で上限10万円、原則1～3割の自己負担）。浴槽内いすや入浴用手すりなどの「入浴補助用具」は対象種目となっており、入浴動作に不安を抱えるKさんに対する助言として適切です。

3：不適切

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、地域密着型サービスの一つですが、利用対象者は「要介護1以上」の者に限定されており、要支援認定者（要支援1・2）を対象とした介護予防サービス（予防給付）は設けられていません。要支援2であるKさんは利用できません。

4：不適切

看護小規模多機能型居宅介護（旧・複合型サービス）は、医療ニーズの高い高齢者等に対して「通い」「泊まり」「訪問看護」「訪問介護」を一体的に提供する地域密着型サービスですが、利用対象者は「要介護1以上」の者に限られます（介護予防サービスはありません）。なお、「小規模多機能型居宅介護」には要支援者向けの「介護予防小規模多機能型居宅介護」が存在しますが、「看護小規模多機能型居宅介護」には存在しないため、混同しやすい重要ポイントです。

5：不適切

介護老人保健施設（老健）に入所できるのは、「要介護1以上」の認定を受けた者です。要支援認定者は施設入所の対象外となります（要支援者が利用できるのは、短期滞在型の「介護予防短期入所療養介護」などに限られます）。

【予想問題】高齢者福祉（福祉用具貸与・特定福祉用具販売の制度と種目）

問題 10 介護保険制度における福祉用具の保険給付（福祉用具貸与・特定福祉用具販売）に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 排泄予測支援機器は、排尿の機会を事前に感知して利用者に知らせる機器であるため、特定福祉用具販売ではなく、福祉用具貸与の対象種目とされている。

2 指定福祉用具貸与事業者は、介護支援専門員（ケアマネジャー）が居宅サービス計画を作成している場合、福祉用具専門相談員による福祉用具サービス計画の作成を省略できる。

3 特殊寝台や車いすなどの種目については、自立支援を促進する観点から、要支援者や要介護1の軽度者も原則として福祉用具貸与の対象に含まれている。

4 特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、要介護度にかかわらず、同一年度（4月1日から翌年3月31日まで）につき10万円と定められている。

5 移動用リフトを使用する場合、利用者の身体に直接装着する吊り具の部分は、福祉用具貸与の対象品目として給付される。

｜【解答と解説】

正解：4

1：不適切

「排泄予測支援機器」（膀胱内の尿量を測定して排尿タイミングを予測・通知する機器）は、肌に直接触れる性質等から、「特定福祉用具販売（購入費の支給対象）」の種目として位置づけられています。福祉用具貸与の対象ではありません。

2：不適切

指定福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員は、居宅サービス計画が作成されている場合であっても、目標や具体的なサービス内容を定めた「福祉用具サービス計画」を作成しなければなりません（作成の省略は不可）。

3：不適切

「車いす」「特殊寝台」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」「移動用リフト」などの種目は、過剰な依存を防ぎ状態像に合った支援を行うため、要支援1・2および要介護1の軽度者に対しては「原則として保険給付（貸与）の対象外」とされています（医学的見地から必要と認められる場合などの例外措置を除く）。

4：適切

特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、要介護度にかかわらず「同一年度（4月1日～翌年3月31日）につき10万円」と定められています。利用者は原則として自己負担分（1～3割）を支払い、残りの9～7割分が介護保険から支給されます。

5：不適切

移動用リフトのうち、床走行式や固定式などのリフト本体は「福祉用具貸与」の対象ですが、利用者の身体に直接装着する「吊り具の部分」は、他人が再利用することになじまないため「特定福祉用具販売（購入費の支給対象）」となります。

【予想問題】高齢者福祉（介護保険制度における各機関の役割と責務）

問題 11 介護保険制度における国、都道府県、市町村、関係機関の役割や権限に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 市町村は、要介護認定等の処分に不服がある被保険者からの審査請求を審理・裁決するため、介護保険審査会を設置する。
- 2 市町村は、介護保険事業の運営の安定化を図るため、保険料の未納や給付費の急増等による財政の不足に対応する財政安定化基金を設置する。
- 3 厚生労働大臣は、地域ごとの介護サービス需給状況を勘案し、3年ごとに各市町村が徴収すべき第1号被保険者の介護保険料率を一元的に決定・告示する。
- 4 市町村は、介護保険サービスの質の向上を図るため、介護支援専門員実務研修受講試験の実施および介護支援専門員証の交付を行う。
- 5 国民健康保険団体連合会は、市町村からの委託を受けて、介護サービス事業者からの介護給付費の請求に関する審査及び支払を行う。

｜【解答と解説】

正解：5

1：不適切

要介護認定・要支援認定の処分や保険料の賦課・徴収などの処分に対する不服申立て（審査請求）を審理・裁決する機関である「介護保険審査会」は、「都道府県」に設置されます（介護保険法第183条）。保険者である市町村自らが処分を審査するわけではありません。

2：不適切

介護保険事業の財政の安定化を図るための「財政安定化基金」は、「都道府県」に設置されます（介護保険法第147条）。市町村の介護保険財政に予期せぬ不足（保険料の収納不足や給付費の急増）が生じた場合に、資金の貸付や交付を行います。

3：不適切

第1号被保険者の介護保険料率は、国の決定ではなく、各市町村がそれぞれの「市町村介護保険事業計画」において定める基準に基づき、3年ごとに市町村の「条例」で設定します。

4：不適切

介護支援専門員（ケアマネジャー）の実務研修受講試験の実施、登録、実務研修・更新研修等の実施、および介護支援専門員証の交付を行うのは、市町村ではなく「都道府県（都道府県知事）」の役割・権限です（一部事務を指定機関に委託可能）。

5：適切

国民健康保険団体連合会（国保連）は、介護保険法第176条に基づき、市町村（保険者）からの委託を受けて、介護サービス事業者からの介護給付費の請求に関する「審査及び支払」を行います。また、介護サービスに関する利用者からの苦情処理業務や、指定基準違反の疑い等に関する調査業務なども担っています。

【予想問題】高齢者福祉（地域支援事業・包括的支援事業の機能強化と多職種連携）

問題 12 事例を読んで、地域包括支援センターのM社会福祉士が、この時点でNさんへの支援のために検討すべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕

身寄りがなく一人暮らしをしているNさん（78歳、男性）について、民生委員から「最近、物忘れが目立ち、近所とのトラブルも増えている。声をかけても『自分はどこも悪くない』と怒り出す」と地域包括支援センターに相談があった。M社会福祉士が訪問したところ、室内は散乱し、同じ日用品を何重にも買い置きしている様子が見られたが、親族等の頼れる身寄りはおらず、Nさんは医療機関への受診や介護保険サービスの利用を頑なに拒否している。要介護認定は受けておらず、かかりつけ医もいない状態である。

- 1 本人の自立した生活を維持するため、一般介護予防事業の「地域介護予防活動支援事業」による専門職の訪問リハビリテーションの導入を提案した。
- 2 医療機関の受診や介護保険サービスへの導入を図るため、専門職で構成される「認知症初期集中支援チーム」による訪問や初期支援の活用を検討した。
- 3 医療と介護の連携を図るため、「在宅医療・介護連携推進事業」の担当窓口に連絡し、本人の同意を得ない形での精神科訪問診療や入院手続きの調整を依頼した。
- 4 地域資源を活用した見守り体制を構築するため、「生活支援体制整備事業」の協議体（第2層）において、Nさんの個別ケアプランの作成や支援内容の調整を進めることとした。
- 5 頼れる親族がいないNさんの権利擁護を図るため、「成年後見制度利用支援事業」を活用し、地域包括支援センターが申立人となって家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう手続きを進めた。

｜【解答と解説】

正解：2

1：不適切

一般介護予防事業の「地域介護予防活動支援事業」は、市町村が住民主体の通いの場等の育成・支援や、多様な主体による介護予防活動の広がりを支援する事業です。個別ケースに対して専門職による訪問リハビリテーションを直接導入・提供する事業ではありません。

2：適切

認知症初期集中支援推進事業（認知症初期集中支援チーム）は、地域包括支援センター等に配置され、認知症専門医や医療・保健・福祉の専門職（看護師、作業療法士、社会福祉士等）で構成されます。認知症の疑いがありながら医療機関を受診していない者や、介護サービスを利用していない（または拒否している）者などを対象に、家庭を訪問してアセスメントや医療機

関の受診勧奨、適切なサービス導入支援等をおおむね最長6か月間、集中的に行います。本事例のNさんの状況に最も合致した対応です。

3：不適切

「在宅医療・介護連携推進事業」は、地域の医療機関と介護事業所の連携体制の構築、在宅医療・介護関係者の研修、市民への普及啓発等を推進する包括的支援事業の一つです。本人の同意なく精神科の訪問診療や医療保護入院等の手続きを調整・代行する枠組みではありません。

4：不適切

「生活支援体制整備事業」における協議体（第2層）は、日常生活圏域（中学校区等）において住民や関係団体等の多様な主体が参画し、生活支援・介護予防に関する地域資源の開発やネットワーク構築、地域の共通課題を検討・共有する場です。個別の対象者に対するケアプラン（居宅サービス計画等）の作成や支援調整を行う場ではありません。

5：不適切

法定後見開始の審判において、申立権を持つのは本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長等であり、地域包括支援センター（または社会福祉士個人）が自ら申立人となることはできません。身寄りがない高齢者の権利擁護が必要な場合は、老人福祉法に基づく「市町村長申立て」の要件を確認し、市町村長による申立てに向けた実態調査や書類作成等の支援を行います。

【予想問題】高齢者福祉（地域包括支援センターの包括的支援事業と多職種協働・地域支援）

問題 13 事例を読んで、地域包括支援センターのP社会福祉士が、この時点でQ介護支援専門員（ケアマネジャー）への後方支援として助言・対応すべきこととして、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕

地域包括支援センターのP社会福祉士は、居宅介護支援事業所のQ介護支援専門員から、「担当している一人暮らしのRさん（79歳、要介護1）への支援について相談したい」と連絡を受けた。Rさんは軽度の認知機能低下と下肢筋力の低下があるが、通所介護を利用しながら自宅での生活を継続している。Rさんには近隣に頼れる親族がおらず、ゴミ出しや電球交換といった日常生活上のちょっとした困りごとを頼める人がいないため、Qはやむを得ず訪問のたびに業務外の無償の支援（シャドーワーク）として自ら対応してきた。しかし、Qは業務負担が増大し、本来のケアマネジメント業務への影響も懸念されることから、今後の対応について苦慮している。

1 Qが行っている業務外の支援は介護保険の適正な運営を損なう恐れがあるため、運営指導（実地指導等）の対象とするよう、市町村の指導監査担当窓口へ報告した。

2 Rさんの日常生活の困りごとを解消しQの負担を軽減するため、日常生活圏域を担当する「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」等と連携し、住民主体のボランティア等の地域資源の活用・調整を助言した。

3 Rさんの生活支援ニーズを満たすインフォーマルサービスを公的給付化するため、都道府県の「介護保険審査会」に対して新たな保険給付項目の追加を要請した。

4 Qの業務負担を軽減するため、Rさんのケアプラン作成業務を居宅介護支援から地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントへ移行させるよう提案した。

5 地域の見守りや生活支援ネットワークを構築するため、都道府県の「国民健康保険団体連合会」に対し、多職種協働による地域ケア会議の招集と運営を依頼した。

｜【解答と解説】

正解：2

1：不適切

居宅介護支援事業所の指定・監督権限は市町村にあります。地域包括支援センターの「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」は、地域のケアマネジャーが抱える困難事例や業務負担（保険給付外の生活支援を無償で抱え込むシャドーワーク問題など）に対して、孤立させずに助言や連携支援を行う「後方支援（支援的役割）」を担うものです。ケアマネジャーを指導・処分の対象として市町村の指導監査窓口へ報告・通報する対応は不適切です。

2：適切

介護保険の公的給付サービス（フォーマルサービス）では対応が難しいゴミ出しや電球交換等の生活支援ニーズに対して、ケアマネジャーが個人的なシャドーワークとして抱え込むのを防ぐためには、包括的支援事業の「生活支援体制整備事業」に配置されている生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や協議体と連携し、住民主体のボランティア、NPO、シルバー人材センター等のインフォーマルサービス（地域資源）を発掘・調整してつなぐことが極めて適切です。

3：不適切

「介護保険審査会」は、市町村が行った要介護認定や保険料の賦課・徴収などの処分に対する被保険者からの不服申立て（審査請求）を審理・裁決する都道府県の附属機関です。新たな給付項目を設定・要請するような権限はありません。

4：不適切

地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメント（介護予防支援）の対象者は、要支援認定を受けた者（要支援1・2）や事業対象者です。本事例のRさんは「要介護1」の認定を受けているため、居宅介護支援の対象であり、介護予防ケアマネジメントへ移行させることはできません。

5：不適切

地域ケア会議の設置・運営主体は「市町村および地域包括支援センター」です。国民健康保険

団体連合会（国保連）は介護給付費の請求審査・支払や苦情処理等を担う機関であり、地域ケア会議の招集・運営を行う機関ではありません。

【予想問題】高齢者福祉（高齢者虐待防止法の規定と養護者支援・通報義務）

問題 14 「高齢者虐待防止法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 市町村は、養護者の心身の疲労の回復その他高齢者虐待の防止に資するため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとされている。
- 2 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、その生命又は身体に重大な危険が生じていない場合であっても、市町村への通報が義務づけられている。
- 3 養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する通報について、守秘義務との関係から、当該施設の従事者自身による通報は認められておらず、外部の第三者に限られている。
- 4 市町村長は、立入調査の実施にあたり、養護者が正当な理由なく立ち入りを拒否したときは、地方裁判所の裁判官が発する令状を得て強制的に居所へ立ち入ることができる。
- 5 都道府県知事は、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況や講じた措置について、市町村からの報告を取りまとめ、毎年度公表するよう努めなければならない。

（注）「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

｜【解答と解説】

正解：1

1：適切

高齢者虐待防止法第14条第1項において、「市町村は、養護者の心身の疲労の回復その他の養護者による高齢者虐待の防止に資するため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする」と規定されています。高齢者虐待防止法は、虐待を受けた高齢者の保護だけでなく、介護疲れ等に直面する「養護者（家族等）に対する支援」を重視している点が大きな特徴です。

2：不適切

養護者による高齢者虐待を発見した者の通報について、高齢者の「生命又は身体に重大な危険が生じている場合」は市町村への通報が「義務」とされていますが、それ以外の場合（生命・身体に重大な危険が生じていない場合）は通報するよう「努めなければならない（努力義務）」と規定されています（法第7条第1項・第2項）。「重大な危険が生じていない場合であっても通報が義務づけられている」とする記述は誤りです。

3：不適切

養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、発見者が外部の第三者であるか当該施設の職員自身であるかを問わず、速やかに市町村に通報しなければなりません（法第 21 条第 1 項）。また、通報を行った従事者は、刑法その他個別の守秘義務規定にかかわらず守秘義務違反には問われないこと、および通報を理由とした解雇その他不利益な取扱いが禁止されていることが同法に明記されています。

4：不適切

市町村長は、立入調査を実施する際に協力を得られない場合、所轄の「警察署長に対し援助を求めることができる」と規定されています（法第 12 条）。なお、裁判所の令状による強制的な「臨検・搜索」の規定は児童虐待防止法には設けられていますが、高齢者虐待防止法には規定されていません（他法との混同を誘う頻出パターンです）。

5：不適切

高齢者虐待防止法第 25 条において、「都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合に採った措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする（義務）」と規定されています。努力義務ではありません。